

Fecha Última Actualización: 03-01-2023 4:44:21

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Rosa Vergara Flores

Edad : 78a 7m 6d

Dirección : Pj Cerro El Kilo 0622 Vi Nosedal 2

Rut : 5.035.088-6

Fecha Nacto: 28/05/1944

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9921494

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 4076 6283

N° Epicrisis

335729

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion

Fecha Ingreso : 30/12/2022 19:35

Días Estadía : 4

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 03/01/2023 04:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso

AM: Postrada post hospitalización por heria diafragmatica y sepsis foco respiratorio, prolongada en UPC 04/-07/22 con multiples intercurencia infecciosas (KPC, K BLEE, burkoellia)

AQ: hernia diafragmatica

A: -

M: pregabalina

Paciente con antecedentes descritos traída por familiar, refiere peak febril 37.8° hace 2 días asociado a CEG. Niega vomitos, diarrea, disnea, dolor toracico. Atendida inicialmente en APS donde pesquisan requerimientos de oxigeno por lo que derivan.

Examen Fisico

Paciente ingresa taquicardica, normotensa, taquipneica, sat 89% con 6 lt por venturi, afebril. Vigil, desorientada en tiempo y espacio

Llene capilar < 2 s

enflaquecida +++++

Postura tonica brazo y mano izquierda

MP (+), crepitos bibasales

RRS2T, no ausculto soplos

EEII sin edema, sin signos de TVP

Plan:

- Hospitalizo

- Rxtx

- Exámenes

- PCR COVID

- Tazonam empirico

Diagnóstico: Insuficiencia Respiratoria Aguda

Fecha Epicrisis : 03/01/2023 04:44

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

M. Pérez
Evolucion día
1er día de hospitalización

Diagnosticos:

1. Insuficiencia respiratoria aguda
- NAC
2. Antecedentes: Postrada post hospitalización por hernia diafragmatica y sepsis foco respiratorio, prolongada en UPC 04/-07/22 con mutiples intercurencia infecciosas (KPC, K BLEE, burkoellia)

Paciente hemodinamicamente estable, afebril, requerimientos de oxigeno 4L por naricera

Bien hidratada bien perfundida
Ritmo regular en dos tiempos no ausculto soplos
Murmulo pulmonar presente crepitos bilaterales
Abdomen blando, depresible, indoloro
EEII sin edema ni signos de TVP
Hemodinamia: estable, no es conflicto
Respiratorio: paciente ingresa con dg de Neumonia, con altos requerimientos de oxigeno con conexion al ingreso a CNAF, durante la mañana se cambia a naricera 4L bien tolerado, PCR 222. En manejo con kinesioterapia respiratoria y antibioterapia con tazonam debido a ant de hospitalización reciente con multiples intercurencias infecciosas. Control seriado de parametros inflamatorios.
- Sin falla de otros organos

Manejo proporcional No RCP, NO IOT

01/01/2023 09:42:02
A. Hamilton
2do día hospitalización

Diagnósticos:

1. Insuficiencia respiratoria aguda
- NAC
2. Antecedentes: dependiente, hospitalización por hernia diafragmatica y sepsis foco respiratorio, prolongada en UPC 04/-07/22 con mutiples intercurencia infecciosas (KPC, K BLEE, burkoellia)

Pcte en regulares condiciones, ayer apoyo O2 a la baja, logrando cambiar CNAF inicial a naricera. Sin embargo, hoy comienza nuevamente taquipneica y con mayor requerimiento de O2, por lo que se conecta nuevamente a CNAF. Hemodinamicamente estable, afebril.

RCG, vigil, desorientada, estable hemodinamicamente. Se mantiene con grandes requerimientos de O2, conectada a CNAF, posición semisentada. RR2t ss, MP (+) se auscultan crepitaciones y roncus bilaterales. Abdomen BDI; sin signos de irritación peritoneal. EEII sin edema ni signos de TVP.
Hemodinamia: estable, sin conflicto actual

Respiratorio: paciente ingresa con dg de Neumonia, parámetros inflamatorios elevados con PCR 222, además de altos requerimientos de oxigeno con conexion al ingreso a CNAF, durante la mañana de ayer se cambia a naricera 4L bien tolerado, no obstante, comienza con mayor apremio hoy, requiriendo ser conectada nuevamente. En manejo con kinesioterapia respiratoria y antibioterapia con tazonam debido a ant de hospitalización reciente con multiples intercurencias infecciosas. Se mantiene tratamiento y se solicita control de exámenes.

Manejo proporcional No RCP, NO IOT

02/01/2023 12:45:01

O.Marichales

MUD DIA

FI 30-12-22

Diagnosticos:

1. Insuficiencia respiratoria aguda

- NAC

2. Antecedentes: Postrada post hospitalización por hernia diafragmática y sepsis foco respiratorio, prolongada en UPC 04/-07/22 con múltiples intercurrentes infecciosas (KPC, K BLEE, Burkholderia)

Evolucion

Paciente con deterioro clínico, en Sopor, Glasgow 4/15 (AO 2- V 1- M 1)

SV en Monitor PA 118/56 PAM 74 FC 105lpm Sat 90% con 15l MR.

Hemodinamia estable, perfundida

Torax mala mecánica ventilatoria UMA++

RR2T NAS

MP (+) Disminuidos, Crepitos anabos campos pulmonares

EEL sin edema Sin signos de TVP.

Hemodinamia : Autosostenida, mantiene monitorización no invasiva.

Respiratorio: BIC de Morfina, titular según mecánica, Oxigenoterapia por NRC. Infeccioso: Parámetros inflamatorio al alza, Mantengo Tratamiento con Tazonam. Solicito laboratorios control.

Medio Interno / Renal: Sin falla renal. Hipokalemia que se trató con carga de CLK, solicito control de ELP.

Social: Me comunico con familiar entrego información sobre estado actual de la paciente.

Manejo proporcional

No DVA

No RCP, NO IOT

03/01/2023 04:28:21

O.Marichales

3:45

Se constata fallecimiento de la paciente

Se da aviso a familiares

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 03/01/2023 04:44



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 03-01-2023 4:44:21

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Oragnys Marichales Vallenilla
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 03/01/2023 04:44

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:06

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar